

Objectif 1 :

1) L'occlusion intestinale aigüe est :

- A. L'arrêt complet des matières ou des gaz
- B. L'urgence la plus fréquente en chirurgie
- C. L'arrêt intermittent du transit
- D. Due à un obstacle siégeant entre l'angle duodéno-jéjunal et l'anus
- E. Une affection qui peut se voir à n'importe quel âge

Objectif 2 :

2) Le syndrome occlusif mécanique peut être en rapport avec :

- A. Une strangulation
- B. Un trouble métabolique
- C. Une obstruction
- D. une prise médicamenteuse
- E. La mise en action du système autonome digestif (sympathique et parasympathique)

3) L'occlusion intestinale aigüe par obturation :

- A. Est une occlusion fonctionnelle
- B. N'intéresse que le colon
- C. Peut être secondaire à une cause extrinsèque, pariétale ou endo-luminale
- D. Comprend une occlusion de la lumière digestive et du méso
- E. Expose au risque imminent d'ischémie intestinale

4) L'OIA par strangulation peut être due à :

- A. Une torsion de l'anse autour de son axe
- B. Une péritonite aigüe
- C. Une hernie interne
- D. Une bride
- E. Un iléus biliaire

5) Au cours de l'occlusion intestinale aigüe par obstruction :

- A. L'obstacle peut être secondaire à une fistule bilio-digestive
- B. L'obstacle peut être secondaire à une tumeur de l'ovaire
- C. La striction intéresse non seulement l'intestin mais aussi sa vascularisation
- D. L'obstacle peut être secondaire à une bride post opératoire
- E. L'obstacle peut être secondaire à une invagination intestinale aigüe

6) L'OIA par strangulation peut être due à :

- A. Un infarctus mésentérique
- B. Une tumeur du colon
- C. Un étranglement herniaire
- D. Un volvulus du cæcum
- E. Une bride congénitale

7) Une occlusion fonctionnelle :

- A. Peut-être en rapport avec une colique néphrétique
- B. Peut-être secondaire à un foyer infectieux intra-abdominal
- C. Est secondaire à un télescopage d'un segment intestinal dans celui situé immédiatement en aval
- D. Peut donner une occlusion mécanique
- E. Peut-être secondaire à un fécalome

8) Au stade d'ischémie :

- A. La paroi est parsemée de piquetés nécrotiques
- B. L'anse intestinale est ecchymotique, rouge foncé puis violacée.
- C. La paroi intestinale est amincie
- D. La vitalité intestinale est douteuse
- E. La résection intestinale s'impose

9) Au stade de nécrose :

- A. Les ulcérations touchent toutes les couches de la paroi
- B. L'anse est de couleur feuilles mortes
- C. Le risque de perforation est imminent
- D. La vitalité intestinale est douteuse
- E. La résection intestinale est discutée

10) La perforation cœcale diastatique :

- A. Est secondaire à une occlusion intestinale haute
- B. Est secondaire à l'augmentation de la pression intra luminale
- C. Est secondaire à la présence de valvule continente
- D. Est secondaire à une occlusion organique
- E. Se complique par une péritonite purulente

11) La distension intestinale est secondaire :

- A. Au troisième secteur
- B. Au gaz provenant essentiellement de la fermentation
- C. À la perte du pouvoir absorbant
- D. À une altération des plexus nerveux intra-muraux
- E. Au liquide ingéré avant l'épisode aigüe de l'OIA

Objectif 3 :

12) Parmi les conséquences locales de l'occlusion intestinale aigüe :

- A. Une anoxie pariétale
- B. Une distension intestinale
- C. Une stase veineuse et lymphatique
- D. Une déshydratation
- E. Une augmentation du pouvoir absorbant de l'intestin

13) Les conséquences générales de l'occlusion intestinale aigüe sont :

- A. Une déshydratation
- B. Un état de choc septique secondaire à une translocation bactérienne
- C. Un état de choc septique secondaire à une perforation digestive
- D. Une hypertension portale
- E. Surviennent de façon précoce en cas d'obstruction

Objectif 4 :

14) Les signes cardinaux du syndrome occlusif comportent :

- A. La douleur
- B. Les vomissements
- C. L'arrêt des matières et des gaz
- D. Le tympanisme abdominal
- E. Le ballonnement abdominal

15) Le seul signe constant de l'OIA est :

- A. La douleur
- B. Les vomissements
- C. L'arrêt des matières et des gaz
- D. Le tympanisme abdominal
- E. Le ballonnement abdominal

16) Au cours d'une occlusion intestinale aiguë la douleur abdominale :

- A. Évolue de façon continue
- B. Peut être à début progressif
- C. Est intense
- D. Est de siège variable au début
- E. Représente le motif de consultation le plus fréquent

17) Le signe le plus précoce lors d'un syndrome occlusif :

- A. Les vomissements
- B. Le météorisme
- C. L'arrêt des matières et des gaz
- D. Les douleurs abdominales
- E. Les nausées

18) Lors d'un syndrome occlusif, les vomissements :

- A. Sont d'emblée fécaloïdes
- B. Sont précédées de nausées
- C. Soulage souvent les douleurs lors d'une occlusion colique
- D. Sont un signe constant lors d'une occlusion basse
- E. Sont un signe précoce lors d'une occlusion haute

19) L'arrêt des matières et des gaz lors du syndrome occlusif :

- A. Est un signe majeur
- B. Peut-être masqué par une diarrhée
- C. Est intermittent
- D. Est incomplet
- E. Est absent lors d'une occlusion du grêle

20) Lors d'une occlusion intestinale aiguë sans signes de gravité, la palpation abdominale peut trouver :

- A. Un abdomen dépressible
- B. Une résistance élastique
- C. Une contraction douloureuse invincible
- D. Une défense généralisée
- E. Une masse abdominale

21) Le Météorisme abdominal se confirme par :

- A. L'inspection
- B. La palpation
- C. La percussion
- D. L'auscultation
- E. Le toucher rectal

22) Lors d'un syndrome occlusif, l'examen physique peut trouver :

- A. Un météorisme abdominal à l'auscultation
- B. Une sensation de résistance élastique
- C. Des selles au toucher rectale
- D. Des bruits hydro-aérique accentués
- E. Une matité centrale

23) Les signes fonctionnels du syndrome occlusif sont :

- A. Un arrêt de la matière et des gaz
- B. Des vomissements
- C. Une sonorité à la percussion
- D. Des douleurs abdominales
- E. Une ampoule rectale vide

24) Le bilan radiologique au cours d'un syndrome occlusif :

- A. Permet de confirmer le diagnostic d'une occlusion intestinale aiguë
- B. Permet de préciser le siège de l'occlusion
- C. Comporte un lavement baryté
- D. Comporte Une échographie abdominale
- E. Comporte Une radiographie abdomen sans préparation (ASP)

25) Lors d'un syndrome occlusif l'examen radiologique de 1^{ère} intention est :

- A. Une IRM abdominale
- B. Un scanner abdominal
- C. Une radiographie ASP debout de face
- D. Une échographie abdominale
- E. Une opacification digestive haute

26) Au cours d'un syndrome occlusif, la radiographie de l'abdomen sans préparation en position debout :

- A. Est indispensable au diagnostic
- B. Permet d'apporter des éléments du diagnostic de gravité
- C. Aide au diagnostic de siège de l'occlusion
- D. Permet une analyse des reliefs muqueux des anses intestinales
- E. Peut ne pas montrer des niveaux hydro-aériques

27) Les images hydro-aériques :

- A. Sont nettes sur ASP de face couché
- B. Correspondent à des arceaux gazeux et des bulles gazeuses
- C. Sont visibles sur une échographie abdominale
- D. Sont plus hauts que larges au cours d'une occlusion haute
- E. Sont mixtes lors d'une occlusion fonctionnelle

28) Les bulles gazeuses sur la radiographie ASP :

- A. Correspondent à la base d'une anse pleine de liquide
- B. La limite supérieure est régulièrement concave
- C. La limite inférieure est horizontale
- D. Sont plus larges que hautes sur le grêle
- E. La clarté est moins nette au cours d'une occlusion colique

29) Les arceaux gazeux sur la radiographie ASP :

- A. Correspondent à un épanchement à prédominance liquidienne
- B. Occupent le sommet et les 2 jambages de l'anse
- C. La hauteur des deux jambages est toujours identique
- D. La limite inférieure est horizontale
- E. La limite supérieure est convexe

30) Les images hydro-aériques sont :

- A. Plus hauts que large dans les OIA du grêle
- B. Disposés en cadre dans les OIA du grêle
- C. Centraux dans les OIA du colon droit
- D. Peuvent être absentes dans les occlusions du grêle
- E. Absents en cas d'OIA avec nécrose intestinale

31) La radiographie ASP montre au cours d'un syndrome occlusif :

- A. Une paroi externe lisse du colon
- B. Une paroi externe bosselée du grêle
- C. Un épaissement de la paroi du grêle en cas d'occlusion fonctionnelle
- D. Des valvules conniventes sur le colon
- E. Des haustrations sur le grêle

32) Au cours d'une OIA mécanique, le scanner abdominal :

- A. Est l'examen radiologique de référence pour la prise en charge d'une occlusion
- B. Peut montrer des niveaux hydro-aérique
- C. Permet de chercher les signes de gravité
- D. Ne montre le niveau transitionnel
- E. Est moins pratiqué qu'une radiographie standard avec opacification

33) Le scanner abdominal en cas d'OIA :

- A. Est indispensable dans la prise en charge
- B. Peut montrer des signes de souffrance intestinale
- C. Localise le siège de l'obstacle
- D. Distingue entre OIA mécanique et fonctionnelle
- E. Est contre indiqué en cas de suspicion de perforation digestive

Objectif 5 :

34) Les signes cliniques de gravité de l'OIA sont :

- A. La fièvre
- B. Un pli cutané persistant
- C. Une alcalose métabolique
- D. Les douleurs abdominales
- E. Hypotension artérielle

35) Les signes cliniques de gravité de l'OIA sont :

- A. Un terrain d'immunodépression
- B. L'âge jeune
- C. La tachycardie
- D. Les vomissements bilieux
- E. L'anurie

36) Au cours de l'OIA, les signes cliniques de souffrance intestinale sont :

- A. Un météorisme
- B. Une défense généralisée
- C. Une masse abdominale
- D. Un toucher rectal ramenant du sang
- E. Une matité déclive

37) Les signes de souffrance intestinale au cours d'une occlusion intestinale aiguë sont :

- A. La fièvre
- B. La douleur abdominale
- C. Les vomissements répétés
- D. L'hyperleucocytose
- E. Le météorisme abdominal important

38) Les signes radiologiques de gravité d'un syndrome occlusif sont :

- A. Un pneumopéritoine sur le scanner
- B. Une aérobilie
- C. Des Vomissements fécaloïdes
- D. Une pneumatose pariétale
- E. Un caecum pré perforatif

39) Les signes de gravité d'un syndrome occlusif sont :

- A. Un défaut de rehaussement pariétal
- B. Un diamètre caecal à 6 cm
- C. Une douleur à la palpation
- D. Une hypertension artérielle
- E. Une élévation importante de la protéine C réactive

Objectif 6 :

40) Les éléments cliniques en faveur d'une occlusion haute sont :

- A. Des signes physiques plus marqués que les signes fonctionnels
- B. Un météorisme peu important
- C. Un arrêt des matières et des gaz franc
- D. Des vomissements précoces
- E. Une altération rapide de l'état général

41) Les caractéristiques de la douleur en faveur d'une occlusion du grêle sont :

- A. À début brutal
- B. Peu intense
- C. Évoluant par crise
- D. À irradiation en barre
- E. Souvent sous ombilicale

42) Les vomissements au cours d'une occlusion du grêle sont :

- A. Précoces
- B. Fréquents
- C. Biliaires puis alimentaires
- D. Associées à une fièvre
- E. Aggravent la douleur

43) Les signes cliniques en faveur d'une occlusion haute sont :

- A. Un état général conservé
- B. Un météorisme localisé périphérique
- C. Des signes fonctionnels accentués
- D. Un arrêt des matières et des gaz tardif
- E. Des vomissements précoces

44) Les niveaux hydro-aériques sur l'ASP au cours d'une occlusion haute :

- A. Périphériques
- B. Plus larges que hauts
- C. Peu volumineux
- D. Peu nombreux
- E. Disposés selon un axe oblique en haut et à droite

45) Les niveaux hydro-aériques sur la radiographie ASP au cours d'une occlusion haute proximale :

- A. Sont absents
- B. Disposés horizontalement
- C. Les plis intestinaux sont nombreux
- D. Se trouvent au niveau hypocondre gauche
- E. Donnent des images en marche d'escaliers

46) Les niveaux hydro-aériques sur la radiographie ASP au cours d'une occlusion iléale :

- A. Présentent des plis intestinaux rares
- B. Se projettent sur le rachis
- C. Sont hauts
- D. Sont larges
- E. Sont disposés horizontalement

47) Parmi les signes cliniques en faveur d'une occlusion colique :

- A. Les signes fonctionnels sont au premier plan
- B. Les signes physiques sont importants
- C. Le météorisme est important
- D. Les signes généraux sont marqués
- E. Les douleurs sont intenses

48) Les douleurs en faveur d'une occlusion d'origine colique sont :

- A. À début brutal
- B. Intenses
- C. Diffuses
- D. Sous ombilicale
- E. Évoluent par crises

49) Les vomissements au cours d'une occlusion d'origine colique :

- A. Sont précoces
- B. Sont souvent remplacés par des nausées
- C. Quand elles sont bilieuses témoignent de l'ancienneté de l'occlusion
- D. L'aspect fécaloïdes constitue un signe de gravité
- E. Soulagent la douleur

50) Les niveaux hydro-aériques sur l'ASP au cours d'une occlusion basse sont :

- A. Nombreux
- B. Volumineux
- C. Plus larges que hauts
- D. Centraux
- E. En marche d'escalier

51) Concernant l'occlusion mécanique :

- A. Les vomissements sont absents en cas de strangulation
- B. Le 3^{ème} secteur est plus important en cas d'obturation
- C. La distension est plus marquée en cas de strangulation
- D. La nécrose est plus fréquente en cas de strangulation
- E. La strangulation est le mécanisme le plus fréquent

52) Au cours d'une occlusion intestinale aiguë par volvulus du grêle :

- A. Le météorisme abdominal est symétrique
- B. Les vomissements sont d'emblée fécaloïdes
- C. L'auscultation de l'abdomen perçoit un silence auscultatoire
- D. Le péristaltisme des anses est visible à l'inspection de l'abdomen
- E. Les douleurs abdominales évoluent par crise sur un fond continu

53) Une occlusion mécanique par obstruction est évoquée devant :

- A. Un état général conservé
- B. Un météorisme discret
- C. Un gargouillement
- D. La présence de sang au toucher rectale
- E. Une occlusion qui ne cède pas au traitement médical

54) Une occlusion mécanique par strangulation est évoquée devant :

- A. Un début brutal
- B. Des vomissements incessants
- C. Un météorisme indolore
- D. Des ondulations péristaltiques à l'inspection
- E. La présence d'une cicatrice médiane

55) Les caractéristiques de l'OIA fonctionnelle :

- A. Des vomissements sont fécaloïdes
- B. Un début est brutal
- C. Des douleurs à type de crampes
- D. Un silence auscultatoire
- E. Un météorisme diffus

56) Les signes radiologiques d'une occlusion par strangulation sont :

- A. Un arceau unique sur l'ASP
- B. Une infiltration du méso sur le scanner abdominal
- C. Un pneumopéritoine
- D. Un NHA plus larges que hauts
- E. Un signe du tourbillon au scanner avec PDC

57) L'occlusion colique par strangulation est caractérisée par :

- A. Un début brutal
- B. Des douleurs intenses
- C. Un état général conservé
- D. Un borborygme
- E. Un météorisme abdominal asymétrique

58) Un iléus reflexe est caractérisé par :

- A. Un météorisme discret
- B. Une douleur à type de pesanteur
- C. Des vomissements fréquents
- D. Un silence auscultatoire
- E. Des ondulations péristaltiques visible

59) Les éléments radiologiques en faveur d'une occlusion fonctionnelle sont :

- A. Un niveau transitionnel intestinal
- B. Prédominance des images gazeuses
- C. Présence d'une anse sentinelle
- D. Une dilatation gazeuse intéressant le colon sigmoïde
- E. Une Infiltration des mésos

60) Concernant l'occlusion sur bride :

- A. Cause rare d'une occlusion haute
- B. Survient le plus souvent après une chirurgie sous méso colique
- C. Le scanner est indispensable au diagnostic
- D. Le mécanisme peut être une strangulation
- E. Le mécanisme peut être une obturation

61) Parmi les étiologies suivantes, lesquelles peuvent entraîner une occlusion par obstruction :

- A. Iléus biliaire
- B. Bride
- C. Péritonite appendiculaire
- D. Tumeur du colon droit
- E. Invagination intestinale aigüe

62) Parmi les causes d'occlusions mécaniques :

- A. Les tumeurs pariétales intestinales
- B. La diverticulite dans sa forme pseudo-tumorale
- C. L'appendicite aigüe
- D. Le syndrome d'Ogilvie
- E. Fécalome

63) Parmi les étiologies d'une OIA mécanique :

- A. Ischémie intestinale aigüe
- B. Phytobézoard
- C. Hernie inguinale étranglée
- D. Coliques néphrétiques
- E. Hémopéritoine

64) Les occlusions par invagination chez le nourrisson sont :

- A. Fréquentes
- B. Diagnostiquées par la palpation d'une tuméfaction au niveau d'un orifice herniaire
- C. Associées à une douleur d'installation progressive
- D. Parfois, associées à des rectorragies
- E. Diagnostiquées par une TDM abdominale en première intention

65) L'examen clinique d'une hernie étranglée met en évidence une tuméfaction :

- A. Non douloureuse
- B. Impulsive à la toux
- C. Avec des signes inflammatoires en regard
- D. Non réductible
- E. Au niveau d'une cicatrice chirurgicale

66) Concernant le volvulus du colon pelvien :

- A. Est la première cause de l'occlusion colique chez l'adulte
- B. Représente une indication opératoire en urgence
- C. S'associe fréquemment à des rectorragies
- D. Se développe sur un terrain de constipation chronique
- E. Est associé à un dolichocôlon

67) Concernant les occlusions sur cancer colique :

- A. Sont responsables d'environ 30% des occlusions coliques
- B. Sont responsables d'occlusion par compression
- C. Le colon gauche est la localisation la plus fréquente
- D. L'adénocarcinome squirreux constitue la cause la plus fréquente
- E. L'arrêt des matières et des gaz est le plus souvent tardif

68) Concernant les occlusions sur volvulus du sigmoïde :

- A. La constipation chronique constitue un facteur de risque
- B. La longueur du sigmoïde constitue un facteur de risque
- C. La notion de douleurs abdominales qui cèdent spontanément est fréquente
- D. Le tableau clinique s'installe de façon progressive
- E. La douleur abdominale est localisée

Objectif 7 :

69) Le traitement médical d'un syndrome occlusif comporte :

- A. Une réanimation en ambulatoire
- B. Une équilibration hydro-électrolytique
- C. Un remplissage vasculaire
- D. Mise en place d'une sonde rectale
- E. Une surveillance clinico-biologique

70) La mise en place d'une sonde naso-gastrique, au cours de l'OIA, permet de :

- A. Quantifier le 3^{ème} secteur
- B. Traiter un volvulus du grêle
- C. Réduire la distension abdominale
- D. Éviter l'inhalation au moment de l'induction anesthésique
- E. Apprécier la qualité du liquide aspiré

71) Le traitement endoscopique au cours d'une occlusion :

- A. Est le traitement de référence des cancers coliques en occlusion
- B. Est contre-indiqué en présence d'un pneumopéritoine
- C. Est indiqué en présence d'une dilatation caecale à 12 cm
- D. Est indiqué en cas de volvulus du sigmoïde sans signe de souffrance
- E. Permet le traitement d'une occlusion sur bride

72) Le traitement chirurgical au cours d'une OIA :

- A. Est indiqué en cas d'une occlusion mécanique
- B. Est indiqué en présence de signe de souffrance
- C. Est précédé d'une réanimation
- D. Peut être fait par voie élective
- E. Peut être fait par laparoscopie

73) Le traitement chirurgical d'une tumeur sigmoïdienne en occlusion peut être :

- A. Une colostomie d'amont en urgence
- B. Une colostomie par voie élective en présence de NHA type grêle
- C. Une résection du sigmoïde avec anastomose colo-colique
- D. Une intervention de HARTMANN
- E. Une colectomie totale avec anastomose iléo rectale

74) Le traitement du volvulus du colon pelvien en urgence peut être :

- A. Endoscopique
- B. Une résection segmentaire et stomie type HARTMAN
- C. Une résection segmentaire et stomie type Bouilly Volkmann
- D. Lavement au hydrosolubles pour dévolvulation
- E. Une colostomie d'amont

Cas Clinique 1 :

Une femme âgée de 37 ans a soudainement développé, il y a 6 heures, des douleurs abdominales diffuses et paroxystiques, accompagnées de vomissements répétés, d'abord alimentaires puis bilieux.

Depuis ce matin, il y a un arrêt des matières et des gaz.

À l'examen physique, sa température est de 37,5°C.

L'examen de l'abdomen révèle une cicatrice médiane de la césarienne solide sous l'ombilic, une distension abdominale centrale modérée avec tympanisme, et une douleur à la palpation dans cette région.

L'auscultation abdominale ne détecte aucun bruit intestinal.

Les orifices herniaires sont libres.

1) Vous devez faire :

- A. Un ASP
- B. Un bilan rénal et inflammatoire
- C. Une échographie abdominale
- D. Une réhydratation
- E. Une sonde naso-gastrique en aspiration

2) On retient en faveur d'une occlusion haute :

- A. La distension abdominale
- B. La présence de niveaux hydro aérique plus larges que hauts
- C. La présence de silence auscultatoire
- D. L'apyrexie
- E. L'absence de syndrome péritonéal

En postopératoire, le patient a présenté un retard d'émission des gaz.

L'examen clinique et paraclinique a confirmé le diagnostic de péritonite aiguë généralisée due à un lâchage anastomotique.

3) Votre conduite à tenir (CAT) serait :

- A. Antibiothérapie à large spectre, guidée par l'antibiogramme du liquide péritonéal prélevé par ponction écho-guidée
- B. Toilette chirurgicale et reconstruction de l'anastomose digestive
- C. Antibiothérapie et drainage radiologique de l'épanchement
- D. Chirurgie « toilette et stomie », encadrée par une antibiothérapie à large spectre
- E. Chirurgie mini-invasive par laparoscopie pour toilette et drainage, encadrée par une antibiothérapie

Cas Clinique 2 :

Un homme de 75 ans, souffrant de constipation chronique, s'est présenté aux urgences pour une douleur violente et soudaine dans la fosse iliaque gauche, associée à un arrêt des matières et des gaz.

À l'examen, une température de 38,2°C et un abdomen distendu, asymétrique, tympanique et douloureux au niveau de la fosse iliaque gauche ont été observés.

Lors du toucher rectal, des rectorragies ont été constatées.

De point de vue biologique, il présente une numération des globules blancs de 13 500/mm³ et une azotémie à 14 mmol/L

L'ASP montre un aspect en double jambage.

1) Les éléments cliniques et para cliniques en faveur du diagnostic de volvulus du colon pelvien sont :

- A. La constipation chronique
- B. La rectorragie
- C. La distension asymétrique
- D. Douleur violente de la FIG
- E. Double jambage à l'ASP

2) Votre conduite à tenir :

- A. Dévolvulation endoscopique première puis chirurgie urgente en cas d'échec
- B. Traitement médical basé sur l'aspiration de la sonde nasogastrique
- C. Chirurgie en urgence
- D. Tentative initiale de réduction du volvulus par lavement baryté
- E. Chirurgie après échec du traitement médical pendant 6 heures

Cas Clinique 3 :

Une femme de 50 ans, diabétique sous insuline, n'ayant jamais subi d'intervention abdominale et présentant des antécédents de diarrhée évoluant depuis six mois, consulte pour des douleurs abdominales vagues qui ont débuté de manière progressive il y a 4 jours.

Ces douleurs sont devenues associées à des vomissements 24 heures plus tard, puis à un arrêt des selles et des gaz 3 jours plus tard.

À l'examen, la patiente est apyrétique, l'abdomen est distendu, tympanique et sensible dans son ensemble.

Les orifices herniaires sont libres.

Le toucher rectal est normal.

L'ASP en position debout montre des niveaux hydro-aériques de type grêliques.

1) Devant ce tableau, quel(s) diagnostic(s) est ou sont à évoquer :

- A. Occlusion sur bride post opératoire
- B. Tumeur du rectum en occlusion
- C. Tumeur du grêle en occlusion
- D. Hernie inguinale étranglée
- E. Maladie de Crohn compliquée de sténose

2) Quel est l'examen complémentaire qu'il faudra réaliser pour établir le diagnostic :

- A. Vidéo capsule
- B. Lavement aux hydrosolubles
- C. Scanner abdominal
- D. Fibroscopie digestive haute
- E. Échographie abdominale

3) Vous prescrivez comme traitement :

- A. Une antibiothérapie
- B. Une rééquilibration hydroélectrolytique
- C. Une aspiration gastrique
- D. Des antalgiques
- E. Des anti inflammatoires

Cas Clinique 4 :

Un homme de 27 ans, qui a subi une appendicectomie par voie de McBurney il y a 3 ans, a présenté brusquement il y a 24 heures une douleur abdominale péri-ombilicale aigüe ainsi que des vomissements.

On note dans les ATCDs familiaux , un frère ayant la maladie de Crohn

L'examen révèle une température de 37,6°C, une cicatrice de McBurney solide, un abdomen distendu, douloureux et tympanique, ainsi qu'un silence auscultatoire sans défense ni contracture

À la radiographie de l'abdomen sans préparation, on observe un niveau hydro-aérique en forme d'arc central, plus large que haut, avec un colon non injecté.

L'examen biologique rénal et inflammatoire est normal

1) Il s'agit d'une :

- A. Occlusion fonctionnelle du grêle
- B. Occlusion sur MICI du grêle « devant l'âge et les ATCDs familiaux »
- C. Occlusion par strangulation du grêle
- D. Occlusion sur bride post opératoire « le plus probable »
- E. Occlusion qui nécessite un traitement chirurgical en urgence

Le patient a été opéré, et lors de l'intervention chirurgicale, une occlusion du grêle sans nécrose a été constatée.

2) Quelle est la procédure à entreprendre ?

- A. Réaliser une stomie digestive
- B. Effectuer une dévolvulation avec fixation du grêle
- C. Pratiquer une section de la bride
- D. Opter pour une résection iléo-caecale avec stomie
- E. Réaliser une résection et une anastomose de la partie malade